

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE AJUSTE MENTAL AL CÁNCER (MAC / MINI-MAC)

Mental Adjustment to Cancer Scale (Watson & Greer, 1988) · Adaptación Española (Ferrero et al., 1995; Watson et al., 1994)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Ajuste Mental al Cáncer (Mental Adjustment to Cancer Scale, MAC / Mini-MAC)
Sigla / Acrónimo	MAC (y su forma abreviada validada internacionalmente Mini-MAC)
Autoría original	Maggie Watson, Steven Greer et al. (The Royal Marsden NHS Foundation Trust, UK, 1988, 1994)
Adaptación en español	Ferrero, Toledo & Barreto (1995, Psiquis / Anales de Psicología); Anarte et al. (2001)
Constructo evaluado	Estilos cognitivos y conductuales específicos de afrontamiento ante el diagnóstico y tratamiento del cáncer
Población diana	Pacientes oncológicos adultos en cualquier fase de la enfermedad (diagnóstico, tratamiento, recidiva o paliativos)
Tiempo de aplicación	8 a 12 minutos (versión 40 ítems) o 5 a 7 minutos (Mini-MAC de 29 ítems)
Estructura y formato	Ítems evaluados en escala Likert de 4 puntos (1 = Definitivamente no se aplica a mí; 4 = Definitivamente sí)
Condiciones de uso	Distribuido bajo registro y autorización oficial de la International Psycho-Oncology Society (IPOS)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El ajuste mental al cáncer se define como las respuestas cognitivas y conductuales que un individuo desarrolla frente al impacto traumático del diagnóstico oncológico, los tratamientos invasivos (quimioterapia, radioterapia, cirugía mutilante) y la amenaza vital inherente. Históricamente, Greer y Watson propusieron que el estilo de afrontamiento no es un mero rasgo estático de personalidad, sino un proceso dinámico de modulación del estrés psicofisiológico.

El marco conceptual del MAC establece cinco estilos principales de afrontamiento: **Espíritu de Lucha (Fighting Spirit)**, **Desesperanza/Indefensión (Helplessness/Hopelessness)**, **Preocupación Ansiosa (Anxious Preoccupation)**, **Fatalismo / Aceptación Pasiva (Fatalism)** y **Evitación Cognitiva (Cognitive Avoidance)**. Estos estilos modulan la calidad de vida, predicen la aparición de trastornos depresivos mayores o de adaptación y se correlacionan con la adherencia a los regímenes oncológicos.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO

Estilo de Afrontamiento	Nº Ítems (Mini-MAC)	Rango	Significación Psicooncológica y Conducta
Espíritu de Lucha	4 ítems	4 - 16	Optimismo activo, búsqueda de control y determinación en vencer la enfermedad
Desesperanza / Indefensión	8 ítems	8 - 32	Sensación de ruina inminente, pérdida de control y rendición pasiva destructiva
Preocupación Ansiosa	8 ítems	8 - 32	Hipervigilancia somática constante, miedo a la recidiva y ansiedad anticipatoria
Fatalismo / Aceptación	5 ítems	5 - 20	Resignación sumisa o fe pasiva ("lo que tenga que ser, será"), sin lucha activa
Evitación Cognitiva	4 ítems	4 - 16	Distracción voluntaria y negativa deliberada a pensar o hablar sobre el cáncer

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ONCOLÓGICA ESPAÑOLA

Consistencia interna	Adecuada fiabilidad en estudios españoles; alfa de Cronbach: Desesperanza $\alpha = 0.86 - 0.89$, Preocupación Ansiosa $\alpha = 0.82 - 0.85$, Espíritu de Lucha $\alpha = 0.74 - 0.79$, Fatalismo $\alpha = 0.65 - 0.72$ (Ferrero et al., 1995).
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 4 semanas: coeficientes de Pearson entre 0.72 y 0.84, demostrando estabilidad en ausencia de cambios médicos drásticos.
Validez de constructo	Análisis factoriales confirman las dimensiones teóricas de Greer y Watson; Desesperanza y Preocupación Ansiosa cargan conjuntamente en un factor de "Afrontamiento Negativo/Distrés".
Validez convergente	Desesperanza correlaciona intensamente con la Escala de Depresión HADS ($r = 0.68$) y BDI ($r = 0.64$); Preocupación Ansiosa con HADS-Ansiedad ($r = 0.71$).
Sensibilidad al cambio	Capaz de registrar mejorías clínicas significativas tras intervenciones de psicoterapia individual centrada en el sentido o programas psicooncológicos cognitivo-conductuales.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Escala de respuesta	Cada ítem se califica de 1 a 4: 1 = Definitivamente no se aplica a mí ; 2 = Rara vez ; 3 = A menudo ; 4 = Definitivamente se aplica a mí .
Cálculo por subescalas	No se calcula una puntuación total única; se obtienen las 5 puntuaciones independientes de cada estilo sumando sus respectivos ítems.
Índice de distrés adaptativo	En investigación clínica se agrupan a menudo las puntuaciones de Desesperanza + Preocupación Ansiosa como indicador compuesto de distrés psicológico oncológico.
Gestión de omisiones	Se tolera como máximo 1 ítem no respondido por subescala, imputando la media del resto de ítems de esa dimensión.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Dimensión MAC	Puntaje Típico	Nivel de Riesgo	Implicación Clínica y Calidad de Vida
Desesperanza	$\geq 18 / 32$	Alto Riesgo Clínico	Marcador crítico de episodio depresivo reactivo mayor y claudicación.
Preocupación Ansiosa	$\geq 20 / 32$	Elevado Distrés	Hipervigilancia autonómica patológica; demandas continuas de pruebas.
Espíritu de Lucha	$< 10 / 16$	Bajo Afrontamiento	Falta de recursos conativos y de autorregulación ante el tratamiento.
Evitación Cognitiva	$\geq 13 / 16$	Riesgo de Negación	Posible evasión de cuidados médicos o retraso en informar recidivas.

PUNTO DE CORTE CRÍTICO EN PSICOONCOLOGÍA:

- **Desesperanza ≥ 18 puntos:** Justifica la interconsulta preferente a Psicooncología / Psiquiatría de Enlace. Este patrón triplica la tasa de abandono de quimioterapia adyuvante y se asocia a pérdida del sentido vital y deseo de adelantar la muerte.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN PSICOONCOLÓGICA PERSONALIZADA

Paso 1: Cribado en Hospital de Día Oncológico: Aplicar el Mini-MAC en momentos clave (inicio de tratamiento o tras malas noticias).

Paso 2: Si predomina Desesperanza/Indefensión (≥ 18):

- Descartar depresión mayor comórbida e ideación suicida encubierta.
- Iniciar psicoterapia de sentido vital (Breitbart) o TCC para reestructuración de indefensión aprendida; valorar antidepresivos si coexisten insomnio y anhedonia.

Paso 3: Si predomina Preocupación Ansiosa (≥ 20):

- Pautar entrenamiento en técnicas de relajación somática y desensibilización sistemática a los ciclos de quimioterapia.
- Establecer citas informativas médicas estructuradas para frenar la búsqueda compulsiva en internet.

Paso 4: Si predomina Evitación Cognitiva Extrema: Verificar que no interfiera con la firma de consentimientos informados ni con la toma de comprimidos orales.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN PSICOONCOLOGÍA

Identificación: Paciente mujer de 49 años, diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de mama estadio IIb, candidata a quimioterapia neoadyuvante seguida de mastectomía. Muestra llanto frecuente y deseos de no operarse.

Evaluación Inicial Mini-MAC:

- Desesperanza / Indefensión = **24 / 32** (Crítica, Percentil 95): Pensamientos de "mi vida está totalmente destruida y no hay nada que hacer".
- Preocupación Ansiosa = **22 / 32** (Severa); Espíritu de Lucha = **6 / 16** (Muy bajo); Fatalismo = **12 / 20**; Evitación = **6 / 16**.

Intervención Psicooncológica: Se activó derivación urgente a la Unidad de Psicooncología: 8 sesiones semanales centradas en el procesamiento emocional del diagnóstico, redefinición de metas a corto plazo y apoyo familiar para la toma de decisiones.

Reevaluación tras la 4ª sesión: Desesperanza descendió a **12 / 32** y el Espíritu de Lucha aumentó a **13 / 16**. La paciente completó el ciclo neoadyuvante con excelente adherencia y aceptó la cirugía reconstructiva con actitud resiliente.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo Vital:

- **Deseo de Adelantar la Muerte:** La desesperanza severa mantenida es el factor más asociado a peticiones de eutanasia prematura o suicidio en cáncer.
- **Abandono Terapéutico:** La combinación de baja lucha y alta evitación conduce al rechazo de tratamientos curativos.

Diagnóstico Diferencial:

- **Trastorno Adaptativo vs. Depresión Mayor:** Evaluar si la reactividad emocional conserva capacidad de disfrute transitorio.
- **Tiranía del Pensamiento Positivo:** Cuidadores que exigen "espíritu de lucha constante" provocan culpa patológica si el paciente sufre tristeza normal.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Ferrero, J., Toledo, M., & Barreto, P. (1995). Adaptación mental al cáncer: evaluación de sus factores en pacientes oncológicos españoles. *Psiquis*, 16(2), 27-36.
- Watson, M., Greer, S., Young, J., Inayat, Q., Burgess, C., & Robertson, B. (1988). Development of a questionnaire measure of adjustment to cancer: the MAC scale. *Psychological Medicine*, 18(1), 203-209. <https://doi.org/10.1017/s0033291700002026>
- Watson, M., Law, M., dos Santos, M., Greer, S., Baruch, J., & Bliss, J. (1994). The Mini-MAC: Further development of the Mental Adjustment to Cancer scale. *Journal of Psychosocial Oncology*, 12(3), 33-46. https://doi.org/10.1300/J077V12N03_03
- Anarte, M. T., Esteve, R., Ramírez, C., & López, A. E. (2001). Adaptación al castellano de la escala Mini-MAC para pacientes con cáncer. *Psicothema*, 13(2), 298-304.